

ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΤΙΔΑ

Γενικά: Η οξεία επιγλωττίτιδα είναι μια σοβαρή, ταχέως εξελισσόμενη βακτηριακή λοίμωξη της επιγλωττίδας και των πέριξ ιστών, η οποία συχνά μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη της κατώτερης αεροφόρας οδού, σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικό arrest. Προσβάλλει κυρίως παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών. Η νόσος δεν εμφανίζει εποχιακή κατανομή.

Ο οπίσθιος ρινοφάρυγγας αποτελεί την κύρια πηγή παθογόνων στην οξεία επιγλωττίτιδα. Ένας μικρός τραυματισμός της επιθηλιακής επιφάνειας (π.χ. μια βλάβη του βλεννογόνου κατά τη διάρκεια μιας ιογενούς λοίμωξης ή από το φαγητό κατά τη διάρκεια της κατάποσης) μπορεί να αποτελέσει προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης της νόσου.

Τα τελευταία χρόνια, η επιδημιολογία της νόσου αφορά κυρίως μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, ενώ η συχνότητα της νόσου στα μικρά παιδιά τείνει να μειωθεί, διότι εφαρμόζεται συστηματικά πλέον ο εμβολιασμός κατά του *Haemophilus influenzae type B* (Hib), ο οποίος αποτελεί και το κύριο βακτηρίδιο που ενοχοποιείται για την οξεία επιγλωττίτιδα.

Εκτός από τον Αιμόφιλο τύπου B, άλλα βακτηρίδια που μπορεί να προκαλέσουν οξεία επιγλωττίτιδα, είναι ο *Streptococcus pyogenes* (GABHS), ο *Streptococcus pneumoniae*, όπως επίσης και ο *Staphylococcus aureus* (MSSA και CA-MRSA). Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μπορεί να προκληθεί από *Pseudomonas aeruginosa*, από *Candida* και *Aspergillus*, ενώ ως επιλοίμωξη βακτηριακών λοιμώξεων μπορεί να ενοχοποιηθούν οι ερπητοϊοί (*HSV-1*, *HSV-2*, *EBV*, *VZV*), οι ιοί της ινφλουένζας (τύπος A & B) και παραϊνφλουένζας (τύπος 1 & 3).

Επιγλωττίδα σε ενήλικες θεωρείται γενικά ασυνήθιστη, αν και παραδόξως εμφανίζει ένα μέγιστο επίπτωσης σε ηλικίες 35-40 ετών. Εκτός από τα προαναφερθέντα λοιμογόνα αίτια, η επιγλωττίτιδα μπορεί να οφείλεται σε εισπνευστικό έγκαυμα, σε κάπνισμα crack-κοκαΐνης, μετά από τοπική ακτινοβολία για θεραπεία όγκων στην περιοχή του τραχήλου, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Πρόκειται για άκρως επείγουσα κατάσταση, που εμφανίζεται αιφνίδια, με υψηλό πυρετό ($\Theta > 38,5^\circ\text{C}$), ενώ εντός ολίγων ωρών το παιδί εμφανίζεται τοξικό (σηπτικό), παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια, δυσφαγία, δυσφωνία και σιελόρροια (**4D: Dyspnea, Dysphagia, Dysphonia, Drooling**).

Το πάσχον παιδί αρνείται επίμονα να ξαπλώσει (ώστε να διατηρεί ανοικτούς αεραγωγούς) και λαμβάνει καθιστή θέση εισπνοής, με ανοιχτό στόμα και με πρόσθια κλίση του κορμού («θέση τρίποδος»), ενώ μπορεί επίσης να αναφέρει πόνο στον λαιμό (στο ύψος του υοειδούς οστού) ή να μιλάει με δυσκολία με παραμορφωμένη φωνή δίκην «ξεστής πατάτας στο στόμα». Ο βήχας μπορεί να είναι ήπιος ή να απουσιάζει.

Χωρίς άμεση, ταχεία, ψύχραιμη και σωστή θεραπευτική παρέμβαση επέρχεται σταδιακά ωχρότητα, κυάνωση, λήθαργο, απώλεια συνείδησης, κώμα και θάνατος. Απώτερες επιπλοκές είναι το επιγλωττιδικό απόστημα ή εμπύημα, το κοκκίωμα φωνητικών χορδών, η σήψη, κ.ά.

Η διάγνωση της οξείας επιγλωττίτιδας τίθεται μόνο κλινικά. Λόγω του επαπειλούμενου αεραγωγού, οι όποιες κλινικο-εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να ακολουθούν μετά την εξασφάλιση του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση.

Η λήψη φαρυγγικών επιχρισμάτων αντενδείκνυται στην περίπτωση που υπάρχει υποψία οξείας επιγλωττίτιδας, παρά μόνον εφόσον εξασφαλιστεί ο αεραγωγός. Αμφιγνώμια υπάρχει για το εάν πρέπει να διενεργηθεί αιμοληψία και τοποθέτηση ενδοφλέβιας προσπέλασης στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες επιγλωττίτιδας, προτού εξασφαλιστεί ο αεραγωγός. Εφόσον όμως ο αεραγωγός εξασφαλιστεί, λαμβάνονται γενική αίματος, αδρός βιοχημικός έλεγχος (π.χ. *Glu*, *Urea*, *Creat.*, *AST/ALT*, γ -GT, *LDH*, $K^+/Na^+/Ca^{++}$, *CRP*, κ.ά.), καλλιέργειες αίματος, καθώς και καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος.

Οι καλλιέργειες αίματος αποβαίνουν θετικές στο 80% περίπου, ενώ οι καλλιέργειες του φαρυγγικού επιχρίσματος είναι διαγνωστικές σε ποσοστό μικρότερο του 50%.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Βασικό μέλημά μας είναι η εξασφάλιση ανοικτού αεραγωγού και επαρκούς αερισμού για τον ασθενή. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η θνησιμότητα των παιδιών με επιγλωττίτιδα, στα οποία δεν διενεργήθη ενδοτραχειακή διασωλήνωση, κυμαίνεται περίπου στο 7-10%.
2. Απαγορεύεται η οπτική επισκόπηση του στοματοφάρυγγα, χωρίς να είμαστε έτοιμοι για άμεση ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Αποφεύγουμε τη διέγερση της αεροφόρου οδού με γλωσσοπίεστρο, λαρυγγοσκόπιο για απλή επισκόπηση, στείλεό ή καθετήρα αναρρόφησης Nelaton. Επίσης, απαγορεύεται ο ερεθισμός και η πρόκληση άγχους στο παιδί με άσκοπες ενέργειες (π.χ. αιμοληψία για εξετάσεις χωρίς τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραμμής, λήψη αερίων αίματος, τοποθέτηση σε ύπτια θέση κ.λπ.). Επίσης, δεν απομακρύνουμε το παιδί από την αγκαλιά του γονέα για την κλινική εξέταση, για να μειώσουμε το άγχος του.
3. Οξυγονώνουμε επαρκώς τον ασθενή με προσωπίδα Venturi (28-31% με ροή 6-8 lt/min), έτσι ώστε να διατηρούμε τον κορεσμό οξυγόνου σε επίπεδα $SpO_2 > 88-90\%$. Χορηγούμε εφυγρανθέν οξυγόνο με συσκευή Venturi ή Ambu και προετοιμάζουμε τη διασωλήνωση. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση απαιτεί έμπειρο προσωπικό και την παρουσία ειδικού ωτορινολαρυγγολόγου, γιατί υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κρικοθυρεοτομή ή τραχειοτομία.
4. Υπάρχει επίσης διχογνωμία για την ορθότητα εφαρμογής βρογχοδιαστολής και πιθανώς χρήσης Αδρεναλίνης (δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική) σε συσκευή νεφελοποίησης. Έτσι, μερικές σειρές σε νοσοκομεία του εξωτερικού, χορηγούν αρχικώς:
 - ▶ 1 amp. Berovent / Demoren (*Aerolin + Atrovent*), καθώς και
 - ▶ 1 amp. Pulmicort στη συσκευή νεφελοποίησης, με παροχή O_2 στα 5-8 lt/min.

Αν δεν έχουμε την εμπειρία για διασωλήνωση ή δεν υπάρχει ειδικός έμπειρος ιατρός τότε επαναλαμβάνουμε ανά 10-20 λεπτά την βρογχοδιαστολή με 1 amp. Aerolin ή Berovent και 1 amp. Pulmicort με O_2 (νεφελοποίηση) στα 5-8 lt/min, μέχρι και κατά την ταχεία διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο, φυσικά συνοδεία ιατρού. Στα μεσοδιαστήματα των νεφελοποιήσεων χορηγούμε στον ασθενή υψηλές ροές (6-10 lt/min) εφυγρανθέντος οξυγόνου, με μάσκα Ventouri ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα με συσκευή Hood.

5. Τοποθετούμε άμεσα φλεβική γραμμή (# 22-24 G) με όσο το δυνατόν λιγότερο εργώδεις προσπάθειες για να αποφύγουμε τη διέγερση του παιδιού και χορηγούμε ορό 250-500 ml NaCl 0,45% - D/W 2,5%, ελεγχόμενα στάγδην προς αναπλήρωση υγρών, αφού το νοσούν παιδί αποφεύγει τις καταποτικές κινήσεις και είναι πιθανώς αφυδατωμένο.
6. Η άμεση έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, ενδοφλεβίως, στοχεύοντας πρωτίστως τον Αιμόφιλο, είναι απαραίτητη, μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών. Έτσι χορηγούμε ενδοφλεβίως Κεφαλοσπορίνες (β' και γ' γενεάς), όπως:
 - **Κεφουροξίμη** (*Zinacef*: 50-200 mg/kg/24h, σε 2 δόσεις) ή
 - **Κεφτριαξόνη** (*Rocephin*: 50-100 mg/kg/24h, σε 1 δόση) ή
 - **Κεφοταξίμη** (*Claforan*: 100-200 mg/kg/24h, σε 3 ή 4 δόσεις).

Παράλληλα, επί υποψίας λοίμωξης από MRSA ή από Στρεπτόκοκκους, χορηγείται:

- **Βανκομυκίνη** (*Voncon*: 40 mg/kg/24h, σε 4 δόσεις, σε έγχυση 60-90 λεπτών) ή
- **Κλινδαμυκίνη** (*Dalacin*: 20-40 mg/kg/24h, σε 3-4 διηρημένες δόσεις).

Η χορηγούμενη αντιβιοτική αγωγή – *αναλόγως των αποτελεσμάτων των καλλιιεργειών* – θα αποκλιμακωθεί (εφόσον είναι συνδυαστική αγωγή) και θα ολοκληρωθεί σε 7-10 ημέρες.

7. Η χρήση κορτικοστεροειδών είναι αμφιλεγόμενη, αλλά ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι τα κορτικοστεροειδή μειώνουν τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ή τη ΜΕΘ.

Ο ασθενής μετά την πάροδο 2-4 ημερών, με την υποχώρηση του πυρετού και τη μείωση του οιδήματος που επιβεβαιώνεται από την διαφυγή αέρα γύρω από τον τραχειοσωλήνα, μπορεί να αποσωληνωθεί με ασφάλεια. Η αποδέσμευση του ασθενούς για επιστροφή στην οικία του γίνεται μόνον εφόσον απυρετήσκει εντελώς και παραμένει απύρετος για 48 ώρες.